

Modem: WD 872 672 75 F 29
Unid: HD 369 782 433 E 3E

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J 3669847037 DF

JULIO JUNITI MANAKO

IDADE: 69 PESO: 85 ALTURA: 180 PROFISSÃO: Aposentado (Representante Comercial)

SINTOMAS: Ansiedade / memória

QUEIXAS: Sonolência diurna

MEDICAMENTOS: Ara 2 / Qufagel / Trept / presati / Traienta / Lipidil

MÉDICO: Dra Camila Dal'Ora

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 18-19h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO ☒ SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 2-3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 58,2 e/h SPO2: 88%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS artrite psoriática

14/06/24 Laçação marc. Swift Ex (M)
P=4 - 10 cm H₂O

25/06/24 P=6 - 10 cm H₂O / fixo P=6,6 cm H₂O (mediante)
IAH=1,5 e/h

m de uso: 6h 47m

fuga: 34 e/m (puartil)

☒ direto ao microfone p/ melhorar

fechamento da boca Natacha

05/07 P=6,6 cm H₂O

24 IAH=1,6 e/h

m de uso: 7h 54'

fuga: 30,7 e/m

Natacha

15/07 P=6,6 cm H₂O

24 IAH=1,6 e/h

m de uso: 6h 45'

fuga: 0,3 e/m

Companheiro aparelho Philips

15/08 P=6,6 cm H₂O

24 IAH=3,5 e/h

m de uso: 7h 43'

Deixo Pi=4,5 cm H₂O
Pm=6,5

gua

19/09/24 $P = 4,5 - 6,5 \text{ cmH}_2\text{O}$ / média $P = 5,1 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = $4,1 \text{ e/h}$

m de uso: $7 \text{ h } 20'$

fuga: 42 seg.

* Troca filtro

Bem adaptado
Orienta higiene mascarona

Natasha

03/12/24 $P = 5,0 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = $4,1 \text{ e/h}$

m de uso: $8 \text{ h } 41'$

fuga: 125

Bem ~~de~~ adaptado

Natasha

04/02/25 $P = 5,1 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = $4,9 \text{ e/h}$

m de uso: $7 \text{ h } 35'$

fuga: 34 segundos

Troca filtro

Bem adaptado

Natasha

06/05/25 $P = 5,0 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = $3,5 \text{ e/h}$

m de uso: $7 \text{ h } 29'$

fuga: 0

Troca filtro

Bem adaptado

S/queiros

Natasha

Nome: JULIO JUNTI MANAKO
Data de Nascimento: 7-5-1955
IMC: 26,23
Sexo: Masculino
Data do exame: 08-05-2024

Peso: 85 kg
Altura: 1,80 m
Médico: DR. PEDRO DUCCINI TRINDADE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 08-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

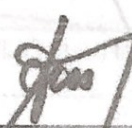
O tempo total de registro foi de 508,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 35,0 e 158,5 minutos. O tempo total de sono foi de 321,5 min, eficiência de 63,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,0%; estágio N2: 69,1%; estágio N3: 11,2%; sono REM: 15,7%. O índice de despertares foi de 30,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 58,2/hora, sendo 46 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 131 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 88%, permanecendo 0,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 65 - 92 bpm e NREM de 66 - 91 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 58,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=88%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,6/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157



CLÍNICA **OPUS**

Indicando CPAP para o
paciente pulso fixo

marako com queda de

SAOS grave: A2H: 58, 2/101

cid 10: G47.3

11/06/24

Dra. Camilla C. Camilla D. D. D. D.
Cm 120.10 RNE 3543

- Alergia e Imunologia
- Cirurgia Plástica da Face
- Endocrinologia
- Endocrinologia Pediátrica
- Fonoaudiologia
- Otorrinolaringologia
- Urologia

Pronto Atendimento Otorrino

clínicaopus.com.br

de Jd Nova América:
rnão Dias, 340 -Jd. Esplanada
42-680 - São José dos Campos-SP